



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA PONEK
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
JUNI 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

LAPORAN KINERJA PONEK BULAN JUNI 2026**RS PRIMA HUSADA MALANG****BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Kesehatan ibu dan bayi baru lahir merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian neonatal (AKN) masih menjadi tantangan besar, di mana banyak kematian tersebut disebabkan oleh komplikasi obstetri dan neonatal yang sebenarnya dapat dicegah melalui penanganan yang cepat dan tepat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, penyebab utama kematian ibu antara lain perdarahan, preeklampsia/eklampsia, infeksi, serta komplikasi persalinan, sementara kematian neonatal sering terjadi akibat asfiksia, infeksi, dan bayi berat lahir rendah (BBLR).

Untuk menurunkan AKI dan AKN, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengembangkan Layanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) sebagai upaya memperkuat sistem rujukan maternal dan neonatal. PONEK merupakan layanan terpadu di rumah sakit yang menyediakan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal 24 jam dengan tenaga kesehatan terlatih, fasilitas memadai, serta standar prosedur yang jelas. Implementasi layanan PONEK secara optimal diharapkan mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

Rumah Sakit Prima Husada adalah sebuah Rumah Sakit Swasta tipe C yang terletak di Banjararum Selatan, Singosari, Malang. Rumah sakit berperan sebagai ujung tombak dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan juga berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas kesehatan maternal-neonatal di Indonesia dan mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat. Demi terselenggaranya keberhasilan PONEK diperlukan dukungan berbagai aspek krusial yang saling terkait, mulai dari penyediaan sumber daya manusia hingga penguatan sistem rujukan.

Pertama, rumah sakit menyiapkan tim medis khusus yang terdiri dari dokter spesialis obstetri-ginekologi, dokter anak, dokter anestesi, dan tenaga bedah, perawat dan bidan yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Kompetensi tim ini terus dijaga melalui program pelatihan berkala dan simulasi kasus gawat darurat. Infrastruktur menjadi pilar penting lainnya. Rumah sakit menyediakan ruang PONEK yang beroperasi 24 jam, dilengkapi dengan ruang bersalin, ruang operasi cesar, serta ruang perawatan intensif untuk ibu (PICU) dan bayi baru lahir (NICU). Kelengkapan alat medis, Laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan cepat dan bank darah yang siap pakai turut mendukung kesiapan penanganan kasus emergensi. Sistem rujukan yang efektif dibangun melalui kerja sama erat dengan fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas

dan klinik.

Protokol klinis yang jelas menjadi panduan tim medis dalam menangani berbagai komplikasi. Rumah sakit menyusun standar operasional prosedur untuk menangani perdarahan, eklampsia, sepsis, dan distosia persalinan, termasuk alur cepat untuk pasien kritis. Audit maternal-perinatal secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kualitas layanan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dukungan administratif dan pendanaan menjadi tulang punggung operasional PONEK. Rumah sakit mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan SDM, pemeliharaan alat, dan penyediaan obat-obatan emergensi.

Laporan bulanan ponek dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran pelayanan PONEK yang ada di RS Prima Husada Malang.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938/Menkes/SK/VII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan serta mengutamakan keselamatan pasien.

1.3.2 Tujuan

1. Memberikan informasi pelayanan PONEK
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan PONEK
3. Menetapkan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit Berkualitas Prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
2. Mengutamakan kepuasan pasien dan keselamatan pasien
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

2.3 Motto

Sahabat menuju sehat

2.4 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adii
7. Peduli



STRUKTUR ORGANISASI TIM PONEK

RS PRIMA HUSADA MALANG

KETUA TIM PONEK

dr. Aida Musyarofah Sp.OG

Sekretaris Tim Ponek :

Siti Zaimah Amd.Keb

Anggota :

1. dr. Arif Heru Wicaksono, Sp.An
2. dr.Dicky, Sp.A. M biomed
3. dr. Isrotul Annisa
4. dr.Yolanda Alifvichasari
5. Triasih, Amd.Keb
6. Elok Oktviana Amd.Keb
7. Rismaya Felantriardianti S.Kep.Ns
8. Leny Puji Rahayu Amd.Keb
9. Anita Sari S.Kep.Ns
10. Bdn.Nining Tri Sari, S.Keb
11. Rita Purnamasari S.Kep.Ns

Analisa	• Jumlah Tim PONEK secara keseluruhan adalah berjumlah 11 orang. Masing - masing anggota memegang jabatan yang berbeda. • Program rotasi: Program rotasi tim PONEK berlaku bila kinerja anggota tidak memenuhi standart tim PONEK dan bila ada anggota yang resign. Pada bulan Juni 2026 tidak ada pergantian anggota Tim PONEK
Rencana Tindak lanjut	• Koordinasi dengan Tim PONEK untuk mengembangkan pelayanan. Serta melakukan pelatihan inhouse training dan Drill Emergency terkait kegawat daruratan maternal Neonatal.

BAB III

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 Pola Ketenagaan

3.1.1 Jumlah SDM

Tabel 3.1.1 Jumlah SDM Tim Ponек RSPHM bulan Juni 2026

Jabatan	Jumlah SDM				Ket.
	Standar	April 2026	Mei 2026	Juni 2026	
Ketua Tim Ponек	1	1	1	1	
Sekretaris Tim Ponек	1	1	1	1	
Anggota Tim Ponек	11	11	11	11	

3.1.2 Pemenuhan kualifikasi SDM

Tabel 3.1.2 Kualifikasi SDM RSPHM Tim Ponек RSPH Juni 2026

Jabatan	Pendidikan	Sertifikasi		Keterangan
	Standar	Ponек (Wajib)	PPGDON (Wajib)	
Ketua Tim Ponек : dr. Aida Musyarofah Sp.OG	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
Sekretaris Tim Ponек : Siti Zaimah Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
1. dr. Arif Heru Wicaksono, Sp.An	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
2. dr. Dicky, Sp.A M biomed	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
3. dr. Isrotul Annisa	Dokter	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Dokter IGD
4. dr.Yolanda Alifvichasari	Dokter	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Dokter IGD
5. Triasih, Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
6. Elok Oktviana Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
7. Rismaya Felantriardianti S.Kep.Ns	Perawat	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Perawat Neonatologi
8. Leny Puji Rahayu Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Bidan Poli
9. Rita Purnamasari S.Kep.Ns	Perawat	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Perawat ICU



Jabatan	Pendidikan	Sertifikasi		Keterangan
	Standar	Ponek (Wajib)	PPGDON (Wajib)	
10. Anita Sari S.Kep.Ns	Perawat	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Perawat IKO
11. Nining Tri Sari,Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	

Analisa	- Jumlah Tim PONEK secara keseluruhan adalah berjumlah 11 orang. Masing - masing anggota memegang jabatan yang berbeda. - Program rotasi: Program rotasi tim PONEK berlaku bila kinerja anggota tidak memenuhi standart tim PONEK dan bila ada anggota yang resign. Pada bulan Juni tidak ada pergantian anggota Tim PONEK 6 anggota tidak melakukan Diklat PPGDON dikarenakan 2 orang dokter IGD, 1 orang perawat Neonatologi, 1 orang perawat ICU, 1 orang perawat IKO saat belum perlu melakukan diklat PPGDON
Rencana Tindak lanjut	- Koordinasi dengan Tim PONEK untuk mengembangkan pelayanan. Serta melakukan pelatihan inhouse training dan Drill Emergency terkait kegawat daruratan maternal Neonatal untuk unit Maternitas, Neonatologi, IGD, ICU,IKO - Pengajuan Diklat PPGDON ke SDM tahun 2026 2 orang

3.1.3 Pelaksanaan Orientasi Khusus di Unit bagi Karyawan baru Ponek RSPH Malang bulan Juni 2026

Tabel 3.1.3. Pelaksanaan Orientasi Khusus di Unit bagi Karyawan baru Ponek RSPH Malang bulan Juni 2026

No	Nama Peserta	Tanggal Masuk	Pembelajaran Yang diterima	Hasil Evaluasi orientasi KHUSUS PONEK								
				Pengetahuan regulasi	Praktek keterampilan	7 nilai budi utama/						
						J	T	V	D	K	A	P
	-											

3.1.4 Hasil Pelaksanaan Peningkatan SDM Tim Ponek di RSPH Malang Bulan Juni 2026

Tabel 1.4 Hasil Pelaksanaan Peningkatan SDM Tim Ponek di RSPH Malang Bulan Juni 2026

NO	Tema DIKLAT /WS/SEM/WB	Jenis Diklat	JUMLAH PESERTA		TGL Pelak sanaan	Hasil evaluasi dalam kinerja sehari-hari
			Hadir	Tidak Hadir		
	-					

3.2. Fasilitas PONEK

Tabel 3.2. Fasilitas Ponek RSPHM bulan Juni 2026

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	USG Transport	Ruang tindakan	1 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
2	USG 4D	Poli kandungan	1	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 4/09/2025
3	IUD SET	Poli kandungan Ruang tindakan	2 set 2 set	Baik Siap Pakai	
4	Inkubator	Perinatologi	5 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
5	Cuvis	Perinatologi	4 unit	Baik Siap Pakai	
6	Monitor ECG	Ruang tindakan	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 2/9/2025
7	Box bayi	Perinatologi	15 unit	Baik Siap Pakai	
8	Fototerapi	Perinatologi	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
9	Suction bayi	Ruang tindakan/ IKO	1 set 1 set	Baik Siap Pakai	
10	Partus Set	Ruang tindakan	7 set	Baik Siap Pakai	
11	Curetage set	Ruang tindakan	4 set	Baik Siap Pakai	
12	Vacum manual	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	



No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
13	Timbangan bayi	Ruang tindakan, NICU, PONEK	3 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
14	NST/CTG	Ruang tindakan, PONEK	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/9/2025
15	Dopler	Ruang tindakan IGD Ponek	2 unit 1 Unit	2 unit baik 1 Unit	Kalibrasi 8/09/2025
16	Infarm warmer	Ruang tindakan. IKO IGD ponek	3 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 3/9/2025
17	Forsep	IKO	1 set	Baik Siap Pakai	
18	C-PAP Mesin	Perinatologi	5 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
19	Vakum set manual	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
20	AmbuBag Bayi	Ruang tindakan	3 set	Baik Siap Pakai	
21	Ambubag Dewasa	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
22	Larigoskop bayi dan anak	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
23	Oxymetri neonates	Ruang perinatologi	1 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
24	Pulse oksimetri neonates baru	Ruang Perinatologi	4 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
25	Sendok kuret makro no 8 dan 10	Ruang Tindakan	2 unit	Baik siap pakai	
26	Micro curret	Ruang Tindakan	1 unit	Baik siap pakai	
27	Sendok Curret	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	
28	HPP set	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	
29	Busi kecil	Ruang Tindakan	2 set	Baik siap pakai	
30	Busi besar	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	
31	Spekulum besar	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	



No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
32	Spekulum sedang	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	
33	Spekulum kecil	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	
34	Nalfuder No 20	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik Siap pakai	
35	Inkubator transport	Ruang Perinatologi	1 Unit	Baik Siap pakai	Kalibrasi 8/09/2025

Analisis :

- 1) Secara umum kondisi fasilitas dan peralatan PONEK cukup lengkap, Khusus alat penunjang medis yang elektrik sudah terkalibrasi
- 2) Bulan Mei tidak ada penambahan alat
- 3) Jadwal kalibrasi rencana bulan September 2026

Rencana Tindak lanjut :

- 1) Melakukan pengecekan alat setiap 1 bulan sekali oleh PJ alat di supervise oleh karu
- 2) Melakukan pemeliharaan alat secara berkala setiap 1 bulan sekali oleh IPSRS
- 3) Melakukan kalibrasi setiap 1 tahun sekali yang rencana akan dilakukan pada bulan September 2026

3.3 Kinerja Produktivitas

3.3.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal

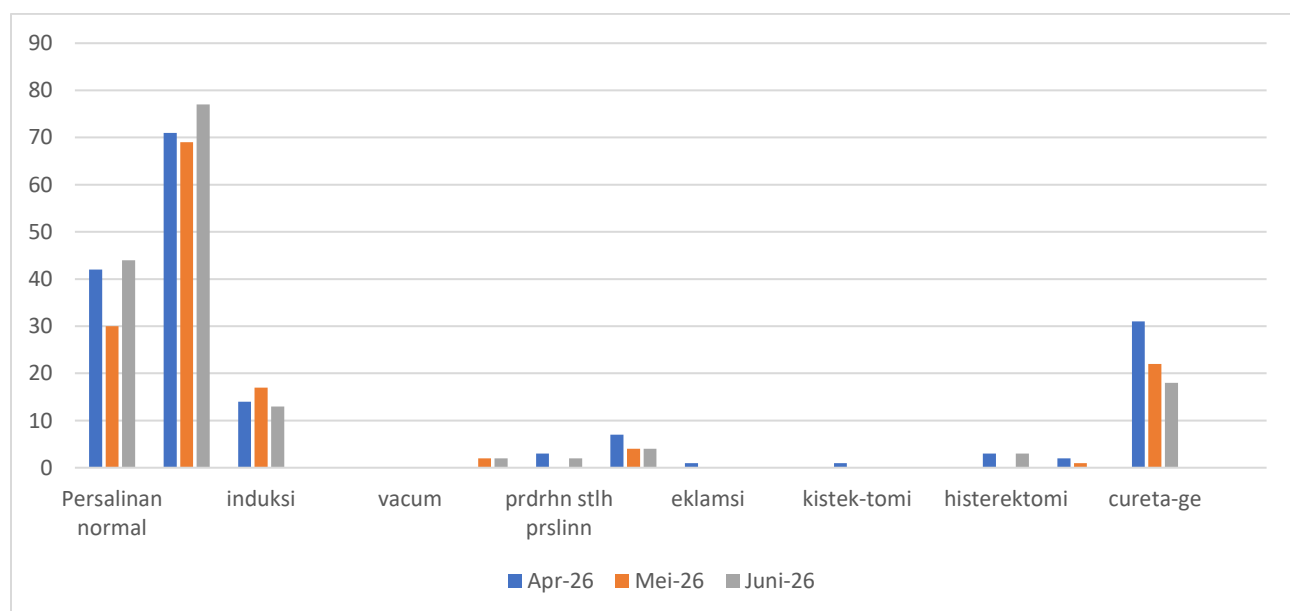
Tabel 3.3.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek RSPHM Juni 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	42	30	44
	b. <i>SectioCaesaria</i>	71	69	77
2				
	a. Induksi / Drip	14	17	13
	b. Sungsang	0	0	0
	c. Vacuum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	2	2
	b. Perdarahan setelah Persalinan	3	0	2
	c. Pre Eklamsi	7	4	4



	d. Eklamsi	1	0	0
	e. Infeksi	0	0	0
4				
	a. Curretage	31	22	18
	b. Kistektomi	1	0	0
	c. Miomektomi	0	0	0
	d. Histerectomy	3	0	3
	e. KET	2	1	0

Grafik 3.3.1
Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis:

- 1) Pada jenis persalinan normal pada bulan Juni 2026 yaitu 44 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 30 pasien, sedangkan bulan April 2026 yaitu 42 pasien
- 2) Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Juni 2026 yaitu 77 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 69 pasien, sedangkan bulan April 2026 yaitu 71 pasien
- 3) Pasien terbanyak yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas SC, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, CPD atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal



distres. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi SC cito.

- 4) Tidak ada persalinan sungsang pada bulan Juni 2026 dan 2 bulan sebelumnya. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Juni 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
- 5) Induksi/ Drip pada bulan Juni sebanyak 13 pasien, menurun dibandingkan bulan Mei sebanyak 17 pasien, dan April 2026 yaitu 14 pasien. Ini disebabkan kontraksi pasien inpartu sudah adekuat sehingga tidak perlu diberikan tambahan induksi/drip.
- 6) Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Juni sama dengan bulan mei 2026 yaitu 4, sedangkan bulan April 2026 yaitu 7 kasus.
- 7) Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah eklamsi. Pada bulan Juni dan Mei 2026 yaitu 0 kasus, menurun dibandingkan dengan bulan April 1 kasus.
- 8) Jenis pelayanan curretage di bulan Juni 2026 yaitu 18 kasus, menurun jika dibandingkan dengan Mei 2026 yaitu 22 kasus, sedangkan bulan April 2026 yaitu 31 pasien. *Curetage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynecology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

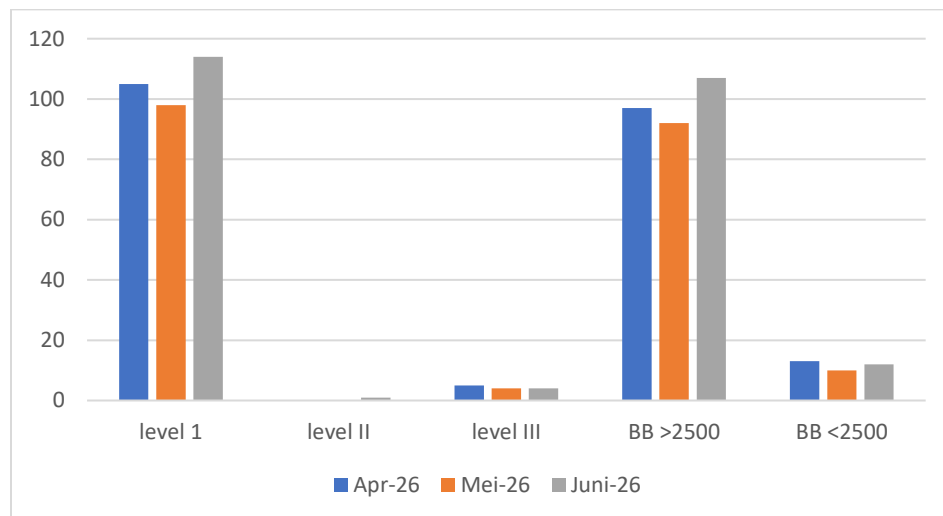
- 1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.
- 5) Melakukan edukasi kepada pasien ANC untuk melakukan senam hamil

3.3.2. Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

Tabel 3.3.2 tabel jumlah kegiatan pelayanan neonatal Ponpek RSPHM Juni 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026
1				
	a. Level 1/ rawat gabung	105	98	114
	b. Level II/ rujukan dari luar	0	0	1
	c. Level III/NICU	5	4	4
2				
	a. BB $\geq$ 2500 gram	97	92	107
	b. BB $\leq$ 2500 gram	13	10	12

Grafik 3.3.2
Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis :

- 1) Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1/ rawat gabung di bulan Juni 2026 yaitu 114 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 98 pasien , sedangkan April 2026 yaitu 105 pasien.
- 2) Pada pelayanan level 2 / rujukan dari luar pada bulan Juni 1 pasien, meningkat dibandingkan bulan Mei dan April 2026 yaitu 0 pasien.
- 3) Pada pelayanan level 3 pada bulan Juni sama dengan bulan Mei yaitu 4 pasien, sedangkan bulan April yaitu 5 pasien.
- 4) Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah BB >2500 gram di bulan Juni 2026 yaitu 107 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 92 pasien, sedangkan bulan April 2026 yaitu 97 pasien
- 5) Jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Juni 2026 yaitu 12 pasien, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 10 pasien, dan April 2026 yaitu 13 pasien. Ini disebabkan karena masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
- 3) Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan



3.3.3 Jumlah Kelahiran Mati Neonatal

Tabel 3.3.3 Jumlah Kelahiran Mati Neonatal RSPHM Bulan Juni 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		April 2026	Mei 2026	Juni 2026
1	Kelahiran Mati /IUFD	2	2	1
2	Mati Neonatal < 7 Hari yang partus di PHM	1	0	2
3	Mati Neonatal < 7 Hari yang rujukan dari luar	1	0	0

Analisis:

- 1) Bulan Juni 2026 ada 1 kasus kelahiran mati/IUFD, sedangkan bulan Mei dan April 2026 ada 2 kasus
- 2) Bulan Juni dan April 2026 ada 1 kasus kematian neonatus <7 hari yang lahir di RS, sedangkan bulan Mei tidak ada kasus.
- 3) Bulan Juni dan Mei 2026 tidak ada kasus kematian neonatus <7 hari yang bayi rujukan, sedangkan bulan April ada 1 kasus.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan Notifikasi di aplikasi MPDN segera 1 x 24 jam untuk semua kematian.
- 2) Melengkapi RMP (Rekam Medis Perinatal) di aplikasi MPDN kurang dari 7 hari untuk bayi IUFD UK > 28 minggu, dan kelahiran bayi mati sampai usia 28 hari
- 3) Melakukan audit maternal neonatal internal RS

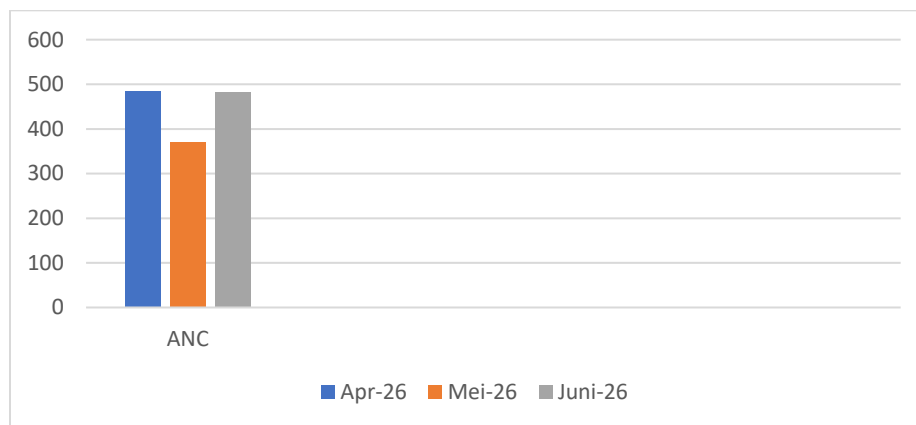
3.3.4 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)

Tabel 3.3.4 Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponek RSPHM Juni 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026
1	ANC	485	371	482

Grafik 3.3.4

Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis

- 1) Berdasarkan data kunjungan Ante Natal Care (ANC), Pada bulan Juni, jumlah kunjungan mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 482 kunjungan. Jika dibandingkan dengan bulan Mei, terjadi peningkatan sebanyak 111 kunjungan atau sekitar 29,9%. Peningkatan kunjungan pada bulan Juni menunjukkan adanya perbaikan cakupan pelayanan antenatal care setelah penurunan yang terjadi pada bulan Mei. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pelayanan dan promosi kesehatan kepada ibu hamil mulai memberikan hasil yang positif.
- 2) Secara keseluruhan, tren kunjungan ANC pada periode April- Juni 2026 menunjukkan kecenderungan meningkat. Meskipun demikian, evaluasi dan pemantauan secara berkala tetap perlu dilakukan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan jumlah kunjungan ANC sehingga seluruh ibu hamil memperoleh pelayanan sesuai standar.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan promosi kesehatan terkait pemeriksaan ANC di dokter spesialis Obgyn
- 2) Melakukan Promosi layanan ANC risiko tinggi
- 3) Melakukan Program kelas ibu hamil

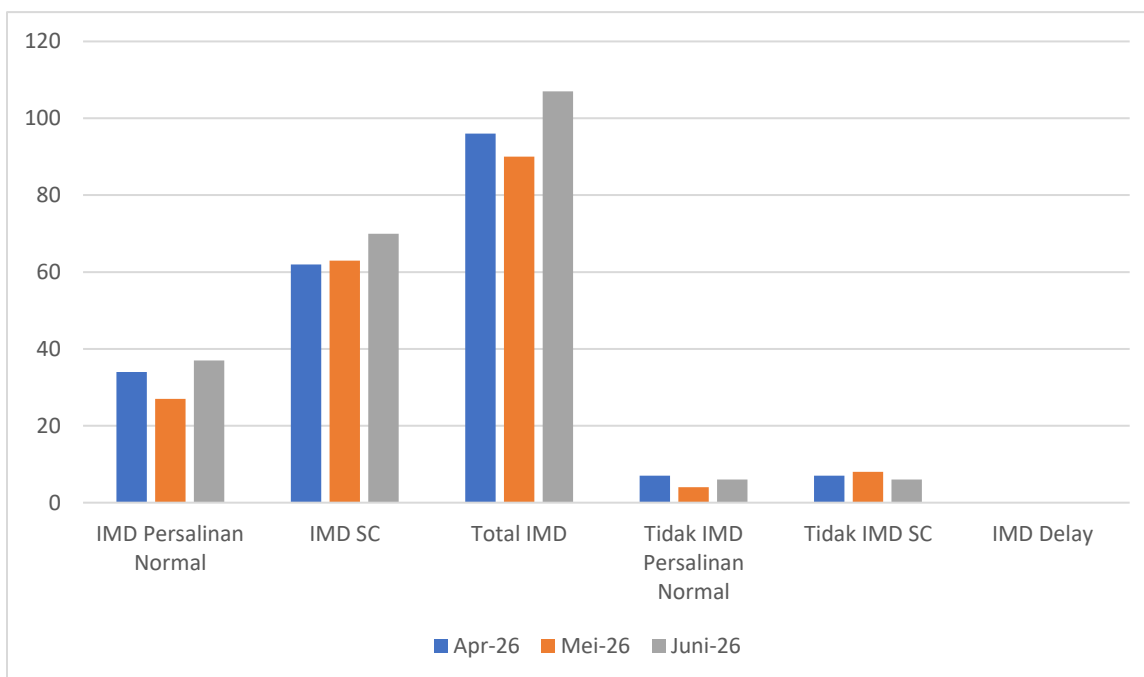


3.3.5 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Tabel 3.3.5 Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) IMD Juni 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien					
		Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%
1	IMD Persalinan Normal	34	82,9%	27	87%	37	86,1%
52	IMD SC	62	89,9%	63	88,7%	70	92,1%
3	Total IMD	96	87,3%	90	88,2%	107	89,9%
4	Tidak IMD Persalinan Normal	7	17,1%	4	12,9%	6	13,9%
5	Tidak IMD SC	7	10,1%	8	11,2%	6	7,9%
6	IMD Delay	0	0%	0	0%	0	0%
	Total Kelahiran Normal	41		31		43	
	Total Kelahiran SC	69		71		76	
	Total kelahiran	110		102		119	

Grafik 3.3.5
Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis :

- 1) Pada bulan Juni 2026 jumlah IMD persalinan normal yaitu 37 (86,1%) pasien, meningkat di bandingkan bulan Mei yaitu 27 (87%) pasien sedangkan bulan April yaitu 34 (82,9%) pasien Bayi.
- 2) Sedangkan IMD pada kelahiran SC pada bulan Juni yaitu 70 (92,1%) pasien, meningkat sedikit dibanding dengan bulan Mei yaitu 63 (88,7%) pasien, dan bulan April 62 (89,9%) pasien.
- 3) Kejadian tidak dilakukan IMD pada persalinan normal bulan Juni yaitu 6 (13,9%) pasien, meningkat dibandingkan bulan Mei yaitu 4 (12,9%), sedangkan bulan April yaitu 7 (17,1%)
- 4) Kejadian tidak dilakukan IMD pada kelahiran SC bulan Juni 2026 yaitu 6 (7,9%) pasien, menurun dibandingkan bulan Mei 2026 yaitu 8 (11,2%) pasien sedangkan bulan April 2026 yaitu 7 (10,1%),
- 5) Bayi yang tidak dilakuan IMD dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD dikarenakan membutuhkan penanganan lebih lanjut seperti bayi BBL dengan perawatan infant warmer, bayi dengan pemakaian CPEP.
- 6) Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan Juni 2026

No	Nama Bayi	Diagnosa	Perawatan BBL
Persalinan Normal			
1	By Ny Eka Safitri	NKB + BBLSR	Inkubator + CPEP



2	By Ny Hartantri	Imatur + BBLASR	Infarn Warmer
3	BY Ny Fitri Ardianingsih	NKB + BBLR	Cuvis
4	By Ny Julia Decha	NCB + BBLR	Infarn Warmer
5	By Ny Zurotun	NCB + Ibu HBSAG reaktif	Infarn warmer
6	By Ny Ni'matus	NCB + Ibu HBSAG reaktif	Infarn Warmer
SC			
1	By Ny Regita Puspita	NCB + BBLR	Cuvis
2	By Ny Ragil Sahita	NKB + BBLSR + Neonatal Hipoglikemi	Cuvis
3	By Ny Luthfia Zulfa 1	NKB + BBLR	Cuvis
4	By Ny Luthfia Zulfa 2	NKB + BBLR	Cuvis
5	By Ny Diah Irmawati	Dyspnew + BBLR	Inkubator + CPEP
6	By Ny Putri F	NKB + BBLSR + RDS	Inkubator + CPEP

Rencana dan Tindak Lanjut

1. Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak
2. Mempertahankan Konsistensi Pelaksanaan IMD
3. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan IMD
4. Edukasi sejak ANC tentang manfaat IMD dan ASI eksklusif.

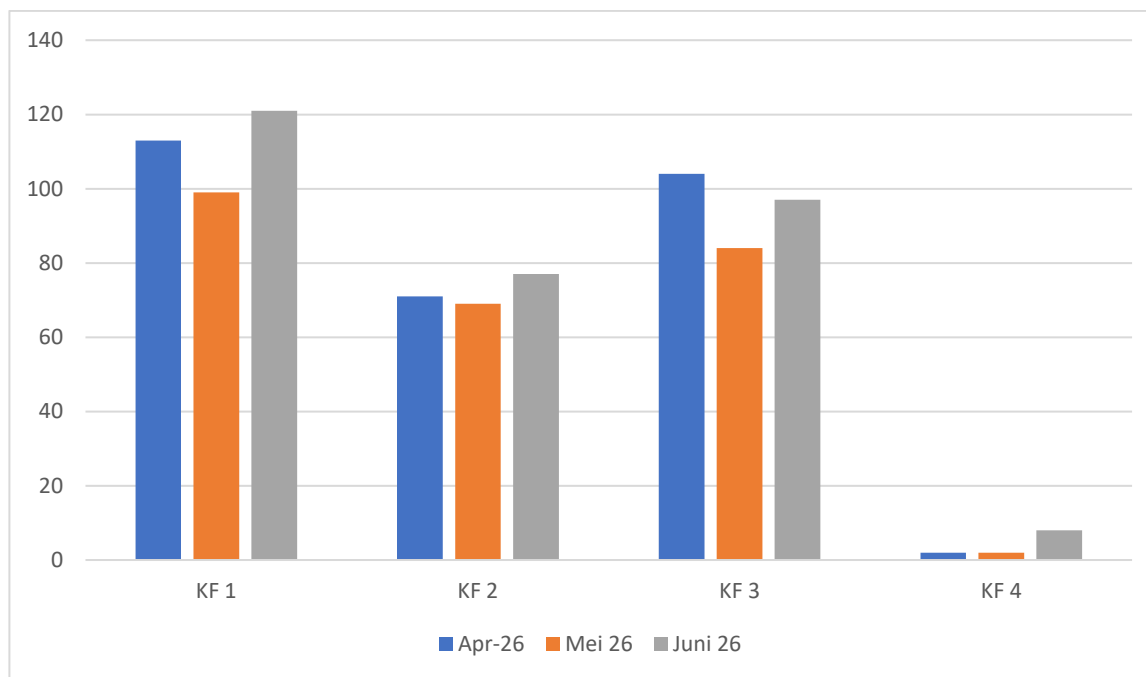
3.3.6 Pelayanan Post Natal Care (PNC)

Tabel 3.3.6 Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek RSPHM Juni 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah					
		Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%
1	KF 1 (6-4 jam)	113	100%	99	100%	121	100%
2	KF2: 3–7 hari	71	62,%	69	69,6%	77	63,6%
3	KF 3 (8- 28 hari)	104	92%	84	84,8 %	97	80,2%
4	KF4: 29–42 hari)	2	2,1%	2	2%	8	6,6%
	Σ kelahiran Normal	42		30		44	
	Σ kelahiran SC	71		69		77	
	Total kelahiran	113		99		121	

Grafik 3.3.6

Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Juni 2026





Analisis:

1. Dari tabel dan grafik 3.3.6 Kunjungan PNC KF 1 pada bulan Juni yaitu 121 pasien (100%), pada bulan Mei yaitu 99 pasien (100%), sedangkan pada bulan April yaitu 113 pasien (100%), ini artinya semua pasien post partum melakukan kunjungan pada KF1
2. Pada kunjungan KF 2 pada bulan Juni yaitu 77 pasien (63,6%), pada bulan Mei yaitu 69 pasien (69,6%), sedangkan pada bulan April yaitu 67 pasien (71,2%), capaian KF 2 belum 100% di karenakan pasien post partum normal hari ke 2 sudah diijinkan pulang dan jadwal kontrol ulang hari ke 8 pasca rawat inap.
3. Pada kunjungan KF 3 pada bulan Juni yaitu 97 pasien (80,2%) pada bulan Mei yaitu 84 pasien (84,8%) sedangkan pada bulan April yaitu 104 pasien (92%) capaian KF 3 belum 100% di karenakan masuk laporan bulan sebelumnya atau bulan setelahnya.
4. Pada kunjungan KF 4 pada bulan Juni yaitu 8 pasien (6,6%), sedangkan pada bulan Mei dan April yaitu 2 pasien (2,1%), %, pada KF 4 cakupan hanya sedikit di karenakan pasien post partum dan post SC setelah kunjungan KF 3 pasien tidak ada komplikasi untuk pemantauan di kembalikan ke faskes 1, pasien KF 4 yang masih bisa di layani di faskes 2 dikarenakan ada masalah seperti infeksi luka operasi atau infeksi jahitan perineum, Tekanan Darah pasien tinggi, evaluasi sisa selaput ketuban.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan Edukasi pasien dan keluarga Jadwal kontrol nifas sesuai jadwal
- 2) Melakukan edukasi tanda bahaya nifas
- 3) Melakukan edukasi pentingnya KB pasca salin
- 4) Melakukan edukasi pemantauan nifas KF 4 di faskes 1

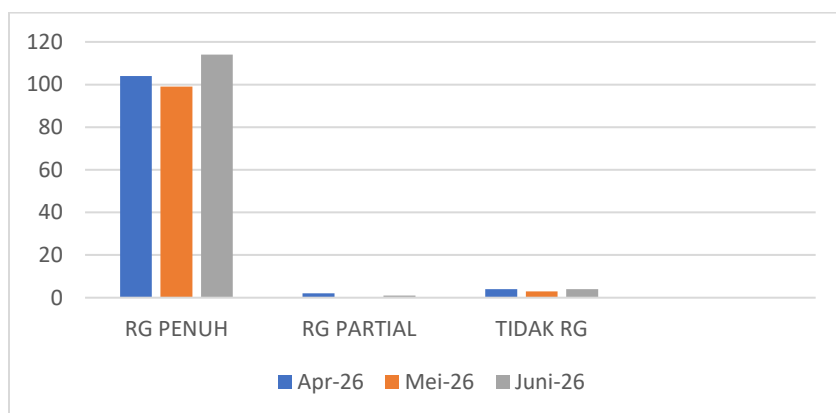
3.3.7 Pelayanan Rawat Gabung

Tabel 3.3.7 Pelayanan Rawat Gabung Ponek RSPHM Juni 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien					
		Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%
1	Rawat gabung penuh	104	94,5%	99	97 %	114	95,8%
2	Rawat gabung partial	2	1,8%	0	0%	1	0,8%
3	Tidak Rawat gabung	4	3,6%	3	2,9%	4	3,4%
Σ Kelahiran		110	-	102	-	119	-

Grafik 3.3.7

Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis :

- 1) Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Juni 2026 yaitu 114 (95,8%) bayi meningkat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 99 (97%) bayi, sedangkan bulan April 2026 yaitu 104 (94,5%) bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2) Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Juni 2026 yaitu 4 (3,4%) bayi, menurun jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 3 (2,9%) bayi, dan April 2026 yaitu 4 (3,6%).
- 3) Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

No	Nama	Diagnosa	Perawatan BBL
1	By Ny Eka Safitri	NKB + BBLSR	Inkubator + CPEP



2	By Ny Hartantri	Imatur + BBLASR	Infarn Warmer
3	By Ny Putri F	NKB + BBLSR + RDS	Inkubator + CPEP
4	By Ny Diah Irmawati	Dyspnew + BBLR	Inkubator + CPEP

- 4) Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

Rencana dan Tindak Lanjut

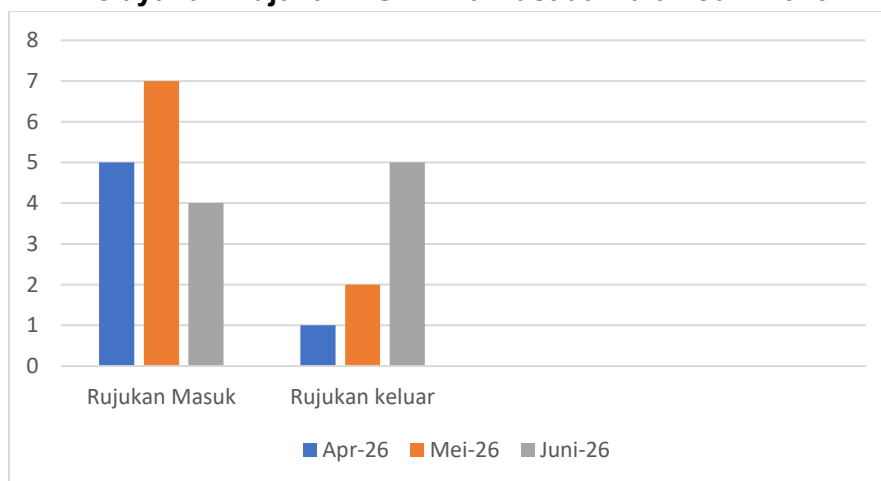
- 1) Setelah kondisi bayi stabil segera dilakukan rawat gabung atau kontak ibu-bayi.
- 2) Fasilitasi ibu untuk memerah ASI sedini mungkin (1–2 jam setelah persalinan)
- 3) Kunjungan ibu ke ruang perinatologi / NICU (jika memungkinkan)
- 4) Pelaksanaan Kangaroo Mother Care pada bayi BBLR yang sudah stabil.

3.3.8 Pelayanan Rujukan

Tabel 3.3.8 Pelayanan Rujukan Ponek RSPHM Juni 2026

No	Rujukan	Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026
1	Rujukan Masuk	5	7	4
2	Rujukan keluar	1	2	5

Grafik 3.3.8
Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Juni 2026



Evaluasi :

- 1) Jumlah rujukan masuk pada bulan Juni 2026 menurun yaitu 4 rujukan, sedangkan pada bulan Mei 2026 menurun yaitu 7 rujukan, dan bulan April 2026 menurun yaitu 5 rujukan
- 2) Jumlah rujukan keluar pada bulan Juni 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 5 rujukan, sedangkan pada bulan Mei 2026 sebanyak 2 rujukan, dan April 2026 sebanyak 1 rujukan rujukan.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM, Puskesmas, Klinik dan RS setempat untuk bekerja sama.
- 2) Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.3.8.1 Rujukan Masuk

Tabel 3.3.8.1 Rujukan Masuk Ponек RSPHM Juni 2026

Bulan April 2026			
1	Ny Chusna W	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KIFA	PKM Singosari
2	NY Dwi Oktavianti	G4 P0000 Ab300 UK 38-39 minggu dengan KET	RSUD Lawang
3	Ny Siti fatonah	G2 P1001 Ab000 UK 37-38 minggu dengan Kala 2 + letsu	PMB Lilik
4	Ny Darwati	Syok hipovolemik ec AUB ec Mioma uteri	PKM Lawang
5	Ny Nina	G1 P0000 Ab000 UK 41-42 minggu dengan Kala 2	PKM Jabung
Bulan Mei 2026			
1	Ny Muspita Sari	G4 P2002 Ab100 UK 18-20 minggu dengan IUFD	KRI Putra Husada
2	Ny Sari Kurnia	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
3	Ny Vio Eka	G1 P0000 Ab000 UK 40 minggu dengan impending ekamsia	Klinik Mutiara Sehat
4	Ny Siti Muyassyaroh	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 minggu dengan KPD	PMB Munawaroh
5	Ny Alfiah	G1 P0000 Ab000 UK 36-37 minggu dengan letsu + partus prematurus + KIFA + IUGR + PER	PMB Titik S
6	Ny Sofi Andini	G3 P1001 Ab100 UK 38-39 minggu dengan KPD + KIFA	PMB Lilik Agustina
7	Ny Anita	G5 P4004 Ab000 UK 10-12 minggu dengan abortus inkomplit	PMB Titik Idmawanti
Bulan Juni 2026			
1	Ny Cindy Lailia	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 minggu dengan KPD	Klinik Mutiara Sehat
2	Ny Tanti W	G2 P0000 Ab100 UK 36-37 minggu dengan KPD	PMB Wahyu Dewi



3	Ny Hernindya	G2 P0000 Ab100 UK 37-38 minggu dengan KIFA	Klinik Divisi 2 kostrad
4	Ny Ananda Rahma	PMB Lilik Agustina	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 minggu dengan KIFA + CPD

3.3.8.2 Rujukan Keluar

Tabel 3.3.8.2 Rujukan Keluar Ponpek RSPHM Juni 2026

No	Nama	Usia	Unit	Diagnosa	Alasan Rujukan	Tujuan Rujukan
Bulan April 2026						
1	By Ny sufiati	1 hari	NICU	RDS ok HMD DD neonatal Pneumonia, BBLASR	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar
Bulan Mei 2026						
1	By Ny Miratus	0 hari	NICU	NKB + BBLR + RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi + pro surfaktan	RS Saiful Anwar
2	By Ny Hindun	4 hari	NICU	Obs distres nafas ok Neonatal Pneumonia dd MAS, susp congenital anomaly dd achondroplasia	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar
Bulan Juni 2026						
1	Ny Syaidah	25 th	Maternitas	G2 P1001 Ab000 UK 10-12 minggu dengan HEG + Hematomesis	Pro Rawat bersama SP.PD- KGEH	RS Saiful Anwar
2	By Ny Endang	1 hari	NICU	NCB + RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Soepraoen
3	By Ny Weni	3 hari	NICU	NKB	Pro Sub Spesialistik Neonatologi + Spesialis bedah anak	RS Saiful Anwar
4	By Ny Eka Safitri	1 hari	NICU	NKB + BBLSR	Pro Sub Spesialistik Neonatologi + pro surfactan	RS Panti Nirmala
5	By Ny Putri	2 hari	NICU	NKB + BBLSR + RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi + pro surfactan	RS Saiful Anwar

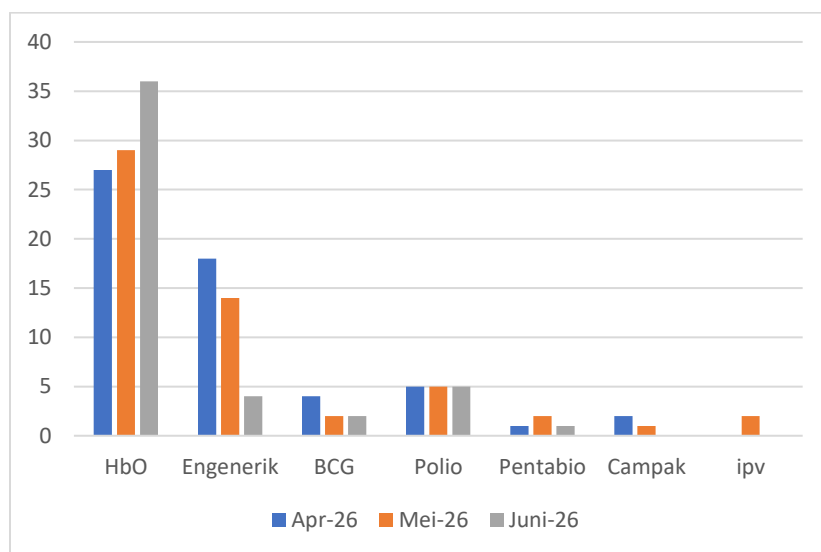
3.4 Pelayanan Imunisasi

Tabel 3.4.1 Pelayanan Imunisasi Ponek RSPHM Juni 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah					
		Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%
1	HbO	27	23,9%	29	28,4%	36	30,2%
2	Engerix Junior	18	15,9%	14	13,7%	4	3,3%
3	BCG	4	-	2	-	2	-
3	Polio	5	-	5	-	5	-
4	Pentabio	1	-	2	-	1	-
5	Campak	2	-	1	-	0	-
6	IPV	0	-	2	-	0	-
	Σ Kelahiran	113		102		119	

Grafik 3.4.1

Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis

- 1) Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Juni 2026 yaitu 36 (30,2%) pasien, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 29 (28,4%) pasien, sedangkan pada bulan April 2026 yaitu 27 (23,9%), dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari atau pembelian vaksin Engerix Junior dengan edukasi Biaya Umum
- 2) Pada bulan Juni ada 4 (3,3%) bayi yang menggunakan vaksin Engerix Junior, menurun dibandingkan pada bulan Mei ada 14 (13,7%) bayi, sedangkan bulan April ada 18 (15,9%) bayi, Penggunaan vaksin Engerix Junior ini dikarenakan banyak nya bayi baru lahir yang tidak mendapatkan vaksin Hbo disebabkan persediaan Hbo yang sedikit, sehingga ditawarkan untuk pembelian Vaksin Engerix Junior.
- 3) Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Juni dan April 2026, sedangkan bulan Mei 2026 sebanyak 2 2026 dan Maret tidak ada.
- 4) Ada 2 bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Juni dan Mei 2026, dan menurun dibandingkan dengan April yaitu 4 bayi.
- 5) Tidak ada bayi yang Imunisasi Campak bulan Mei 2026, sedangkan bulan Mei ada 1 bayi, dan April ada 2 bayi.
- 6) Ada 5 bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Juni dan 2 bulan sebelumnya
- 7) Ada 1 bayi yang melakukan imunisasi Pentabio pada bulan Juni dan April 2026, sedangkan pada bulan Mei ada 2 bayi. Imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2) Melakukan edukasi pemberian imunisasi Engerix Junior untuk bayi baru lahir
- 3) Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.5 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

3.5.1 Pelayanan Pemasangan Keluarga berencana (KB) Ponek RSPHM Juni 2026

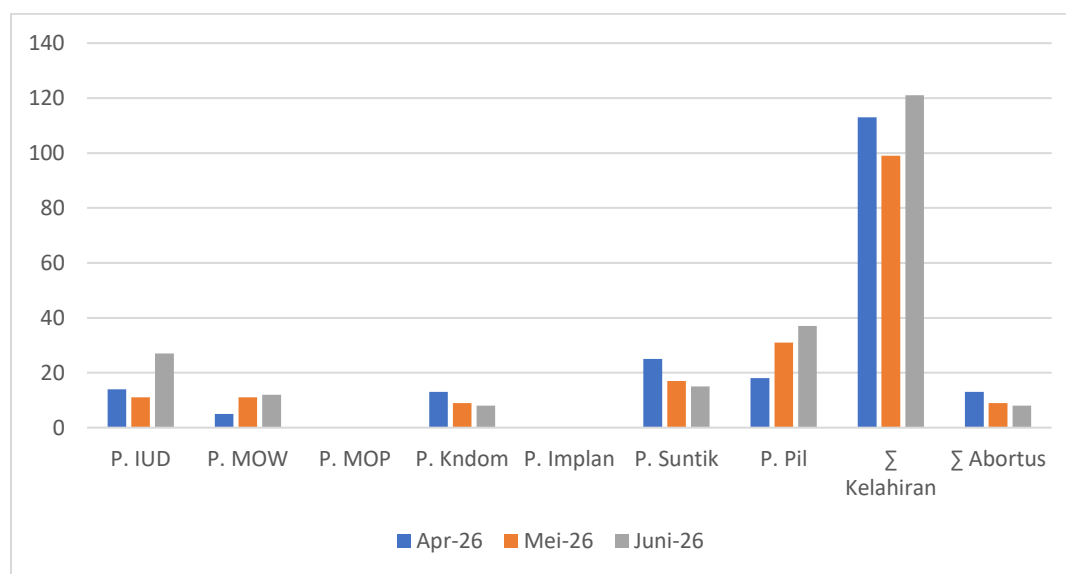
Tabel 3.5.1 Pelayanan Pemasangan Keluarga berencana (KB) Ponek RSPHM Juni 2026

No	Jenis	Jumlah Pasang					
		Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%
1	IUD	14	12,4%	11	11,1%	27	22,3%
2	MOW	5	4,4%	11	11,1%	12	9,9%



3	MOP	0	-	0	-	0	-
4	Kondom	13	100%	9	100%	8	100%
5	Implant	0	-	0	-	0	-
6	Suntikan	25	-	17	-	15	-
7	Pil	18		31		37	-
8	Σ Kelahiran	113		99		121	
9	Σ Abortus	13		9		8	

Grafik 3.5.1
Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2026





Analisis :

- 1) Pemasangan KB IUD pada bulan Juni 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 27 (22,3%) akseptor, pada bulan Mei yaitu 11 (11,1%) sedangkan pada bulan April 14 (12,4%) Pemakaian IUD pasca salin dengan cakupan sedikit dikarenakan ada biaya jasa dokter 400.000 untuk IUD coper T, dan biaya IUD nova T 850.000.
- 2) Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Juni 2026 sebanyak 12 (9,9%) pasien, sedangkan pada bulan Mei 2026 sebanyak 11 (11,1%) dan bulan April 2026 sebanyak 5 (4,4%), pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3) Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Juni 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 8 pasien, sedangkan pada bulan Mei 2026 yaitu 9 pasien dan pada bulan April 2025 sebanyak 13 pasien.
- 4) Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Juni 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 37 pengguna, sedangkan pada bulan Mei 2026 yaitu 31 pengguna, dan bulan April 2026 sebanyak 18 pengguna.
- 5) Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Juni menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 15 pengguna, sedangkan bulan Mei 2026 yaitu 17 pengguna, dan bulan April 2026 sebanyak 25 pengguna.



Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.5. Pelayanan Pelepasan Keluarga Berencana (KB)

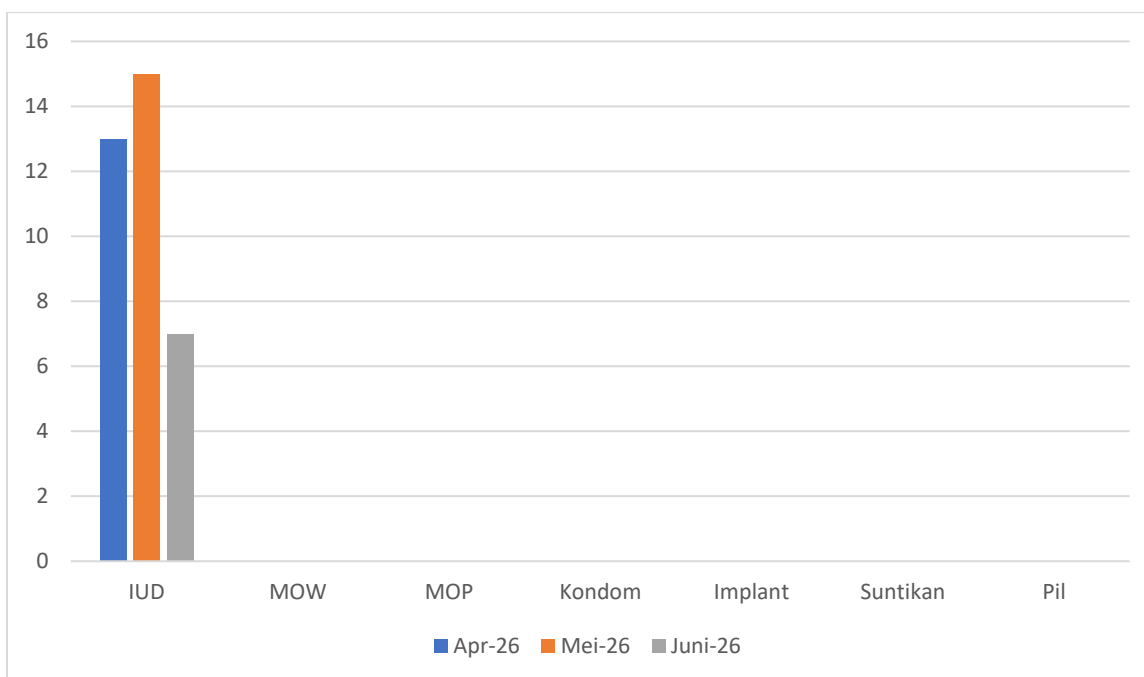
3.5.2 Pelayanan Pelepasan Keluarga berencana (KB) Ponek RSPHM Juni 2026

Tabel 3.5.2 Pelayan Pelepasan Keluarga berencana (KB) Ponek RSPHM Juni 2026

No	Jenis	Jumlah Lepas		
		April 2026	Mei 2026	Juni 2026
1	IUD	13	15	7
2	MOW	0	0	0
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0

Grafik 3.5.2

Pelayanan Pelepasan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2026





Analisis:

1. Pelepasan KB IUD pada bulan Juni 2026 meningkat yaitu 7 Akseptor, sedangkan pada bulan Mei 2026 yaitu 15 Akseptor, dan bulan April 2026 yaitu 13 Akseptor,
2. Pelepasan KB Implan pada bulan Juni 2026 dan 2 bulan sebelumnya tidak ada

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

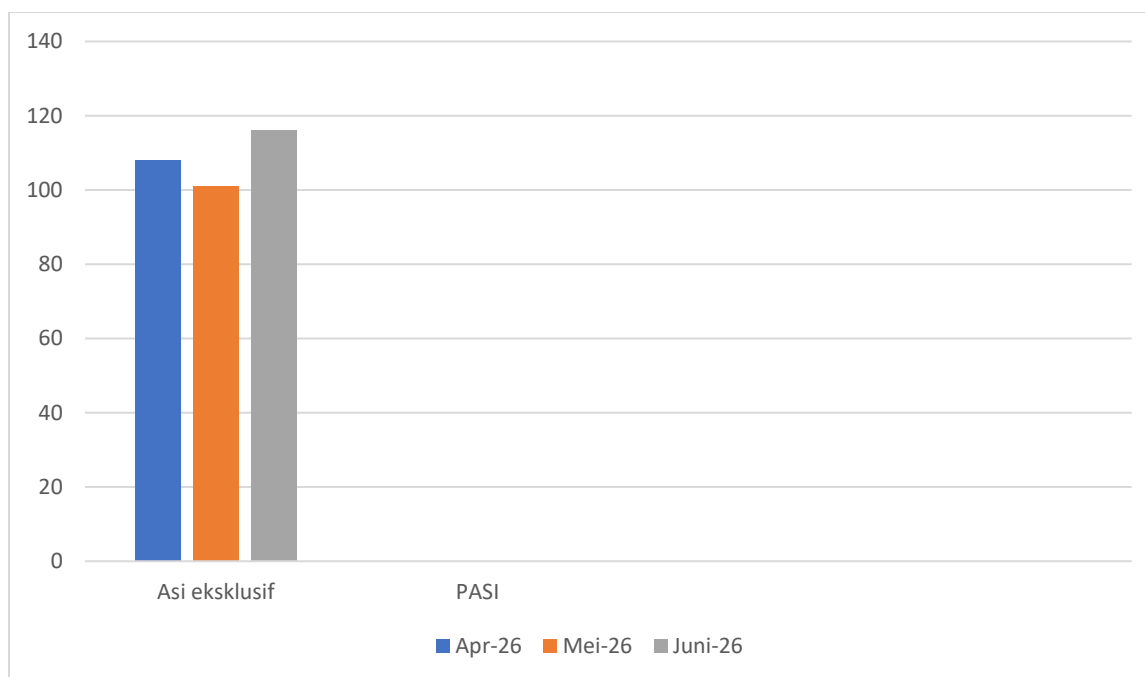
3.3.10. Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel 3.3.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Ponpek RSPHM Juni 2026

No	Pemberian Asi	Jumlah Pasien					
		Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%
1	Asi eksklusif	108	100%	101	100%	116	97,5%
2	PASI	0	0%	0	0%	0	0%
3	Puasa	2		1		3	2,5%
Σ kelahiran		110	-	102	-	119	

Grafik 3.3.10

Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis :

- 1) Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Juni yaitu 116 (97,5%) bayi, pada bulan Mei yaitu 101 (100%) bayi, sedangkan April 2026 yaitu 108 (100%) bayi, Pemberian ASI belum memenuhi target yaitu 100% Hal ini dikarenakan ada bayi yang puasa dikarenakan
- 2) Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan April dan 2 bulan sebelumnya. Bayi yang menggunakan susu formula pada bayi dengan kondisi tertentu, dan atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Edukasi ASI eksklusif sejak antenatal care
- 2) Melakukan konseling laktasi oleh dokter, bidan dan perawat pada ibu pasca lahiran

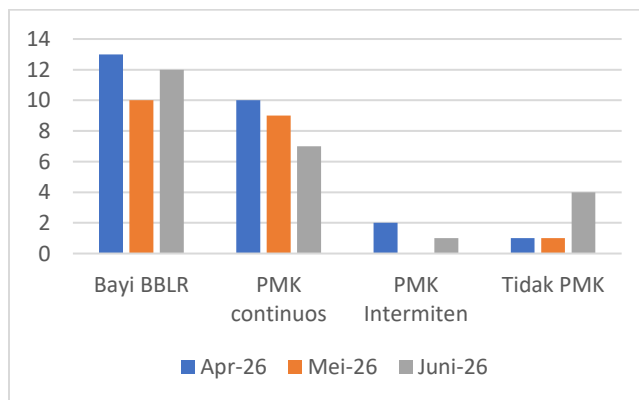
3.3.11. Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel 3.3.11 Pelayanan Perawatan metode kanguru (PMK) Pada BBLR di Ponok RSPHM Bulan Juni 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026
1	Bayi BBLR	13	10	12
2	PMK continuos	10	9	7
3	PMK Intermiten	2	0	1
4	Tidak PMK	1	1	4

Grafik 3.3.11

Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR Di RS Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis :

- 1) Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500 gram.
- 2) Ada 1 pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Juni 2026, sedangkan pada bulan Mei tidak ada , dan April 2026 ada 2 bayi.
- 3) Sedangkan metode PMK continus pada bulan Juni 2026 sebanyak 7 bayi, sedangkan pada bulan Mei 2026 sebanyak 9 bayi , dan April sebanyak 10 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil.
- 4) Ada 4 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Juni 2026, sedangkan pada bulan Mei dan April ada 1 bayi. Hal ini dikarenakan bayi dengan diagnosa NKB, BBLR , dyspnew dan RDS dan bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku
- 2) Memberikan edukasi kepada orang tua bayi untuk melakukan PMK

3.3.12. Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada BBL di Rs Prima Husada Malang

Tabel 3.3.12 Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital Pada BBL di Rs Prima Husada Malang Bulan Juni 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien					
		Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%
1	Bayi SHK	112	99,1%	101	99,1%	116	97,4%
2	Bayi Tidak SHK	1	0,89%	1	0,98%	3	2,5%
Σ Kelahiran		113	-	102	-	119	

Analisis :

1. Pada bulan Juni bayi dilakukan SHK 116 (97,4%) bayi, bayi tidak dilakukan SHK 3 (2,5%) bayi, di karenakan bayi dirujuk kurang dari 24 jam, dan ada 2 bayi yang meninggal dikarenakan imatur dan dyspnew
2. Pada bulan Mei bayi dilakukan SHK 101 (99,1%) bayi, bayi tidak dilakukan SHK 1 (0,98%) bayi, di karenakan bayi dirujuk kurang dari 24 jam
3. Pada bulan April bayi dilakukan SHK 112 (99,1%) bayi, bayi tidak dilakukan SHK 1 (0,89%) bayi, di karenakan bayi dirujuk kurang dari 24 jam

Rencana dan Tindak Lanjut

1. Mempertahankan cakupan SHK $\geq 99\%$ pada seluruh bayi baru lahir
2. Koordinasi dengan rumah sakit penerima rujukan agar bayi yang dirujuk sebelum 24 jam tetap mendapatkan SHK sesuai jadwal.
3. Memberikan KIE kepada orang tua tentang manfaat SHK untuk deteksi dini hipotiroid kongenital dan dampak keterlambatan diagnosis.



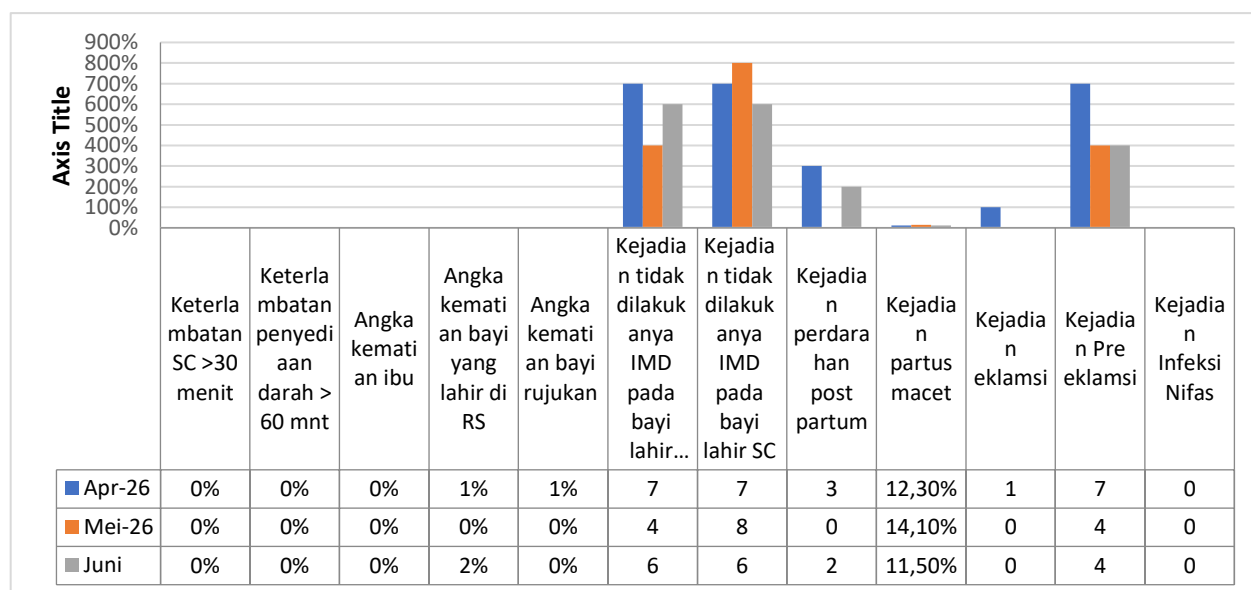
3.4 MUTU

Tabel 3.4 MUTU Ponek RSPHM Mutu bulan Juni 2026

No	Pengukuran Mutu	Standart	Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026
1	Angka keterlambatan operasi section caesaria (SC) >30 menit	0%	0%	0%	0%
2	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%
3	Angka kematian bayi yang lahir di RS	0%	0,9 %	0%	1,6
4	Angka kematian bayi rujukan	0%	0,9 %	0%	0%
5	Kejadian tidak dilakukanya IMD pada bayi lahir	0%	14	12	12
6	Kejadian perdarahan post partum	0	3	0	2
7	Kejadian partus macet	<10%	12,3 %	14,1%	11,5%
8	Kejadian eklamsi	0	1	0	0
9	Kejadian Pre eklamsi	0	7	4	4
10	Kejadian Infeksi Nifas	0	0	0	0

Grafik 3.4

Mutu PONEK Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2026





Analisis :

- 1) Pada Mutu Angka kematian Ibu pada bulan Juni 2026 dan 2 bulan sebelumnya sebanyak 0%. Hal ini dikarenakan tidak ada kasus kematian Ibu.
- 2) Pada Mutu Angka kematian Bayi lahir di RS pada bulan Juni 2026 sebanyak 1,6%, sedangkan pada bulan Mei 2026 sebanyak 0% dan bulan April sebanyak 0,9 %. Hal ini dikarenakan ada 2 kasus kematian bayi pada bulan Mei 2026.
- 3) Pada Mutu Angka kematian Bayi rujukan sebanyak 0% pada bulan Mei 2026. Hal ini dikarenakan tidak ada kasus kematian bayi pada bulan Mei 2026.
- 4) Pada mutu tidak dilakukannya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir persalinan normal Pada bulan Juni 2026 sebanyak 6 bayi, sedangkan tidak dilakukannya IMD pada SC sebanyak 6 bayi.
- 5) Berikut alasan kenapa bayi tidak dilakukannya IMD pada bulan Juni 2026

No	Nama Bayi	Diagnosa	Perawatan BBL
Persalinan Normal			
1	By Ny Eka Safitri	NKB + BBLSR	Inkubator + CPEP
2	By Ny Hartantri	Imatur + BBLASR	Infarn Warmer
3	BY Ny Fitri Ardianingsih	NKB + BBLR	Cuvis
4	By Ny Julia Decha	NCB + BBLR	Infarn Warmer
5	By Ny Zurotun	NCB + Ibu HBSAG reaktif	Infarn warmer
6	By Ny Ni'matus	NCB + Ibu HBSAG reaktif	Infarn Warmer
SC			
1	By Ny Regita Puspita	NCB + BBLR	Cuvis
2	By Ny Ragil Sahita	NKB + BBLSR + Neonatal Hipoglikemi	Cuvis
3	By Ny Luthfia Zulfa 1	NKB + BBLR	Cuvis
4	By Ny Luthfia Zulfa 2	NKB + BBLR	Cuvis
5	By Ny Diah Irmawati	Dyspnew + BBLR	Inkubator + CPEP
6	By Ny Putri F	NKB + BBLSR + RDS	Inkubator + CPEP

Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir dikarenakan bayi lahir dengan BBLR kurang bulan dan Asfiksia, sehingga bayi memerlukan tindakan segera untuk pemasangan alat bantu CPAP dan perawatan incubator. Oleh karena itu bayi tidak dilakukannya IMD. Perawat bayi melakukan IMD sesuai dengan syarat yang telah ditentukan kecuali pada bayi dengan kondisi asfiksia sedang-berat dan kelainan konginetal, pada TM III terjadi peningkatan pada kasus ini, bayi tidak di IMD yang disebabkan karena BBLR dan asfiksia sedang-berat yang membutuhkan perawatan incubator, C-pap dan oksigen.

- 6) Pada kasus pasien pre eklamsi pada bulan Juni dan Mei sebanyak 4 kasus, sedangkan pada bulan April sebanyak 7 kasus. Untuk kasus Eklamsi pada bulan Juni dan Mei tidak ada kasus, kasus, sedangkan pada bulan April ada 1 kasus. Unit terkait akan



berkolaborasi dengan SP. OG dalam melakukan skrining ibu hamil yang beresiko untuk terjadi eklamsi serta mengedukasi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang tidak menimbulkan hipertensi.

- 7) Pada kasus Kejadian partus macet pada bulan Juni 2026 menurun, yaitu sebanyak 11,5 %, sedangkan bulan Mei 2026 yaitu sebanyak 14,1 %, dan bulan April 2026 sebanyak 12,3 %, Kejadian partus macet pada bulan Juni dikarenakan prolong fase laten, prolong fase aktif, dan kala 2 lama, sehingga pasien dilakukannya operasi SC.
- 8) Ada 2 kejadian perdarahan post partum pada bulan Juni 2026, sedangkan pada bulan Mei tidak ada, dan bulan April sebanyak 3 kasus.
- 9) Tidak ada kejadian Infeksi nifas pada bulan Juni dan 2 bulan sebelumnya.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atau tidak.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makanan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) berkolaborasi dengan SP. OG dalam melakukan skrining ibu hamil yang beresiko untuk terjadi eklamsi serta mengedukasi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang tidak menimbulkan hipertensi
- 4) Memberikan Edukasi pada Ibu post Nifas terkait gizi yang dibutuhkan ibu Nifas, agar tidak terjadi lagi kasus infeksi pada Ibu nifas.
- 5) Mengevaluasi tiap bulan peningkatan jumlah Kunci indikator mutu PONEK.
- 6) Koordinasi dengan Tim PMKP untuk melakukan pelaporan dan evaluasi setiap bulan, yang nantinya akan dilaporkan ke direktur Rumah Sakit.

3.5 Kelas Senam hamil

Tabel 3.5 Kelas senam hamil RSPHM Juni 2026

Pengembang an Pelayanan	Hasil kinerja	Analisa	Rencana Tindak Lanjut
Senam Hamil	- Minggu ke 2 : Anggota : 30 peserta Hadir : 23 peserta. - Minggu ke 4 : Anggota : 30 peserta Hadir : 24 peserta .Target : 1 bulan 2 kali. Hasil : 2x/bulan = 47 bumil	- Rata-rata kehadiran bulan Juni senam hamil 78,3% Total persalinan 70% dari senam hamil yang diselenggarakan di PHM, dengan senam hamil ini dapat menambah citra RS yang lebih baik, menambah kunjungan dan semakin banyak orang yg menyukai RS Prima Husada Malang. - Jumlah peserta senam hamil masih belum mencapai target dengan jumlah peserta setiap datang target 30 peserta.	- Berkolaborasi dengan asisten Poli Obgyn untuk mengedukasi pasien hamil uk diatas 22 minggu untuk mengikuti senam hamil. - KIE bahwa kelas senam teradapat Hypnopregnancy yang akan kontinyus dg hypno melahirkan. - Video Promosi senam hamil yang di tampilkan di IG RS dan di prima menyapa

Analisis :

1. Peserta senam hamil pada bulan Juni 2026 yaitu 47 pasien, sedangkan pada bulan Mei 2026 yaitu 39 pasien, dan April 2026 yaitu 44 pasien.
2. Peserta senam hamil pada bulan Juni 2026 yang melahirkan di RS Prima Husada yaitu % pasien, sedangkan yang lain pasien melahirkan di faskes lain.
3. Dari peserta senam hamil yang melahirkan, pasien mengatakan pada proses persalinan senam hamil dan hypnoterapi sangat membantu.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan penjarangan ibu hamil usia kehamilan 22-24 minggu untuk melakukan senam hamil.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil di ruang tunggu poli untuk melakukan senam hamil
- 3) Berkolaborasi dengan PKRS membuat flayer promosi senam hamil yang ditempatkan di ruang tunggu poli obgyn
- 4) Membuat video promosi senam hamil yang di putar di prima menyapa dan di upload di IG RS
- 5) Mengevaluasi tiap bulan peningkatan jumlah peserta senam hamil.
- 6) Koordinasi dengan Tim PKRS untuk melakukan pelaporan dan evaluasi setiap bulan, yang nantinya akan dilaporkan ke direktur Rumah Sakit.

3.6 PKRS

Tabel 3.6 PKRS Ponpek RSPHM Bulan Juni 2026

Kegiatan	Target	April	Mei 2026	Juni 2026
Edukasi kelompok	4x/bl	1. Persiapan persalinan 2. Perawatan bayi baru lahir 3. Persiapan senam hamil 4. Manfaat senam hamil	1. Persiapan persalinan 2. Perawatan bayi baru lahir 3. Persiapan senam hamil 4. Manfaat senam hamil	1. Manajemen Nyeri 2. Perawatan Luka pasca Operasi 3. Hipertensi 4. Ibu Hamil Bebas Anemia
Edukasi individu	100%	1. Asi Eksklusif 2. Perawatan Payudara 3. Pijat laktasi 4. IMD 5. Personal Hygiene 6. KB 7. Edukasi nyeri post SC	1. Asi Eksklusif 2. Perawatan Payudara 3. Pijat laktasi 4. IMD 5. Personal Hygiene 6. KB 7. Edukasi nyeri post SC	1. Asi Eksklusif 2. Perawatan Payudara 3. Pijat laktasi 4. IMD 5. Personal Hygiene 6. KB 7. Edukasi nyeri post SC



Kegiatan	Target			
Pembinaan Jejaring	3x/tahun			

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Monitoring

Tabel 4. 1. Hasil Monitoring Ponpek RSPHM Juni tahun 2026

No	Bulan	Kegiatan	Jumlah yang dipantau/ diobservasi	Hasil Temuan	Akar Masalah	RTL	PIC	Ket
1	Juni	Kejadian perdarahan post partum	2 pasien	Ada 2 kasus perdarahan setelah melahirkan	Atonia Uteri, tidak adekuatnya kontraksi uterus setelah persalinan	1. Edukasi nutrisi pada saat kehamilan 2. Edukasi pasien untuk rutin melakukan ANC 3. Edukasi ibu hamil untuk melakukan senam hamil	Tim Ponpek	
2		Kejadian partus macet	14 pasien	Terdapat kejadian partus macet 11,5%	His dan power pasien tidak adekuat	1. Edukasi pasien saat kemilan untuk melakukan senam hamil dan hypnoterapi 2. Edukasi pasien saat hamil untuk mencukupi kebutuhan nutrisi selama hamil	Tim Ponpek	
3		Kejadian Pre eklamsi	4 pasien	Terdapat kejadian pre eklamsi 4 pasien	Tekanan darah tinggi disetertai hasil pemeriksaan protein urin +	1. Edukasi pasien kepatuhan kontrol kehamilan 2. Edukasi pasein untuk pola makan sehat dan istirahat yang cukup 3. Edukasi pasien untuk keputuhan minum obat	Tim Ponpek	
4		Kejadian Eklamsi	0 pasien	Tidak terdapat kejadian Eklamsi	-	1. Edukasi pasien kepatuhan kontrol kehamilan	Tim Ponpek	



						2. Edukasi pasien untuk pola makan sehat dan istirahat yang cukup 3. Edukasi pasien untuk keputusan minum obat		
5		Program RSSIB : Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi lahir	12 bayi	Bulan Juni terdapat 12 (10,1%) bayi yang tidak dilakukan IMD pada persalinan normal dan SC	Bayi dengan kondisi BBLR, Neonatal kurang bulan	1) Skin-to-Skin Contact setelah stabil, dilakukan di ruang NICU/Perinatologi jika memungkinkan. 2) Early Initiation of Expressed Breast Milk (EBM), Ibu dipandu memerah ASI dalam 1–2 jam pertama dan ASI diberikan melalui metode sesuai kondisi bayi 3) Metode Kangaru Mother Care untuk bayi BBLR stabil.	Tim Ponek	
6		Program RSSIB : edukasi menyusui bayi	60 pasien	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi menyusui bayi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada edukasi menyusui bayi. Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan.	Tim Ponek	



					dicapai sebesar 100%.			
7		Program RSSIB : ASI Eksklusif	60 pasien	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi ASI eksklusif 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada edukasi asi eksklusif. Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan.	Tim Ponek	
8		Program RSSIB : Perawatan payudara	60 pasien	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi Perawatan payudara 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada edukasi perawatan payudara. Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan.	Tim Ponek	



					dicapai sebesar 100%.			
9		Program RSSIB : rawat gabung ibu bayi	60 pasien	Bulan Juni hasil pelaksanaan rawat gabub 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada rawat gabung ibu bayi . Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan.	Tim Ponek	
10		Program RSSIB : makan minum ibu menyusui	60 pasien	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi makan miinum ibu mnyusui 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada edukasi makan miinum ibu mnyusui. Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan.	Tim Ponek	



					dicapai sebesar 100%.			
11		Program RSSIB : Personal Hygiene	60 pasien	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi Personal Hygiene 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada edukasi Personal Hygiene. Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan.	Tim Ponék	
12		Program RSSIB : Pijat Laktasi	60 pasien	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi Pijat laktasi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada edukasi Pijat Laktasi. Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan.	Tim Ponék	



					dicapai sebesar 100%.			
13		Program RSSIB : Perawatan Metode Kanguru	8 bayi	Bulan Juni hasil pelaksanaan perawatan metode kanguru 100% dari pasien yang di observasi 8 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada edukasi perawatan metode kanguru. Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan.		



4.2.Evaluasi

Tabel 4.2. 1 Hasil evaluasi Ponek Juni 2026

Bulan	Masalah yg dibahas	Hasil Temuan	Akar Masalah	RTL	PIC	Ket
Juni	Pelayanan Imunisasi	Bayi baru lahir tidak mendapatkan imunisasi HB0	1.Vaksin Hb0 di puskesmas terbatas, bulan Juni 2026 bayi baru lahir yang mendapatkan vaksin HB0 dari pemerintah yaitu 36 pasien / 30,2%, bayi yang mendapatkan imunisasi Engerix Junior yaitu (vaksin Hb0 swasta) yaitu 4 bayi, sedangkan jumlah kelahiran bulan Juni yaitu sebanyak 119 bayi. 2.Pasien yang melahirkan di RS Prima Husada tidak hanya dari wilayah singosari melainkan dari luar wilayah Puskesmas singosari	1. Koordinasi dengan Puskesmas Singosari untuk pelaporan vaksin 2. Pengadaan vaksin Engerix Junior	Neonatologi	
	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	IUD pasca lahir	1.Pemasangan IUD pasca lahir 22,3% dikarenakan pemasangan IUD berbayar jika dipasang dokter, dan pasien menginginkan KB selain IUD	1. Melakukan edukasi pasien inpartu, rencana SC,pasien abortus	Maternitas	



			2. Pasien memilih KB setelah nifas	2. Edukasi pasien dan penunggu di ruang tunggu poli kandungan oleh PJ KBRS 3. Membuat flayer KB yang ditempatkan di ruang tunggu poli obgyn		
	Program RSSIB : Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi lahir	Bulan Juni terdapat 12 (10,1%) bayi yang tidak dilakukan IMD pada persalinan normal dan SC	Bayi dengan kondisi BBLR, Neonatal kurang bulan tidak dilakukan IMD	1) Skin-to-Skin Contact setelah stabil, dilakukan di ruang NICU/Perinatologi jika memungkinkan. 2) Early Initiation of Expressed Breast Milk (EBM), Ibu dipandu memerah ASI dalam 1–2 jam pertama dan ASI diberikan melalui metode sesuai kondisi bayi 3) Metode Kangaru Mother Care untuk bayi BBLR stabil.	Neonatologi	
	Program RSSIB : edukasi menyusui bayi	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi menyusui bayi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada edukasi menyusui bayi. Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan.	Maternitas	



	Program RSSIB : ASI Eksklusif	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi ASI Eksklusif 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada ASI Eksklusif . Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan.	Maternitas Neonatologi	
	Program RSSIB : Perawatan payudara	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi Perawatan payudara 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada Perawatan payudara . Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan	Maternitas	
	Program RSSIB : Rawat Gabung ibu bayi	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi Rawat gabung ibu bayi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada rawat gabung . Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan	Maternitas Neonatologi	



	Program RSSIB : Makan minum ibu menyusui	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi makan minum ibu menyusui 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada edukasi makan minum ibu menyusui . Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan	Neonatologi	
	Program RSSIB : Personal Hygine	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi Personal Hygine 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada edukasi Personal Hygine . Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan	Maternitas Neonatologi	
	Program RSSIB : Pijat Laktasi	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi Pijat laktasi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada edukasi Pijat laktasi . Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai	Maternitas	



				dasar perbaikan mutu pelayanan		
	Program RSSIB : Edukasi perawatan bayi baru lahir menjemur bayi	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi Edukasi perawatan bayi baru lahir menjemur bayi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada Edukasi perawatan bayi baru lahir menjemur bayi . Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan	Neonatologi	
	Program RSSIB : Edukasi perawatan bayi baru lahir perawatan tali pusat	Bulan Juni hasil pelaksanaan edukasi Edukasi perawatan bayi baru lahir perawatan tali pusat 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada Edukasi perawatan tali pusat. Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan	Neonatologi	
	Program RSSIB : Edukasi	Bulan Juni hasil pelaksanaan Edukasi	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada Edukasi	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar	Neonatologi	



	perawatan bayi baru lahir memandikan bayi	perawatan bayi baru lahir memandikan bayi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan	memandikan. Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan		
	Program RSSIB : Edukasi Perawatan metode kanguru	Bulan Juni hasil pelaksanaan Edukasi Perawatan metode kanguru 100% dari pasien yang di observasi 8 pasien/bulan	Tidak terdapat akar masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program RS Sayang Ibu pada Edukasi Perawatan metode kanguru . Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai rencana dan target capaian program berhasil dicapai sebesar 100%.	1) Mempertahankan pelaksanaan seluruh kegiatan Program RS Sayang Ibu sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan refreshment terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 3) Melaksanakan survei kepuasan pasien secara berkala sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan	Neonatologi	

Tabel 4.2.2 Hasil Rekapitulasi Supervisi Bulan Juni 2026

No.	Komponen yang dinilai	Standar	Dilakukan		Temuan	Tindak Lanjut
			Ya	Tidak		
1	Rumah Sakit menetapkan regulasi tentang pelaksanaan PONEK 24 jam.	PONEK 1 EP 1	√	-	Sudah dilakukan revisi 100%	Melakukan monitoring dan evaluasi
2	Terdapat Tim PONEK yang ditetapkan oleh rumah sakit dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya.	PONEK 1 EP 2	√	-	SK Tim Ponek sudah dilakukan revisi 100%	Melakukan monitoring dan evaluasi
3	Terdapat program kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program PONEK Rumah Sakit maksud dan tujuan.	PONEK 1 EP 3	√	-	Sudah dilakukan revisi 100%	Melakukan monitoring dan evaluasi
4	Terdapat bukti pelaksanaan program PONEK Rumah Sakit	PONEK 1 EP 4	√		Bukti laporan tentang pelaksanaan program PONEK pada Laporan Triwulan PONEK dan sudah di Disposisi Direktur	Melakukan monitoring dan evaluasi
5	Program Ponek Rumah Sakit dipantau dan di evaluasi secara rutin	PONEK 1 EP 5	√		Bukti tentang program PONEK Rumah Sakit dipantau dan dievaluasi secara rutin pada Laporan Triwulan PONEK. pelaksanaan pemberian materi edukasi ke pasien : 1. Imunisasi : Hasil supervisi pelaksanaan Imunisasi HB0 42 % dari 60 pasien bayi baru lahir.. 2. KB : Hasil supervisi pelaksanaan KB pasca persalinan 31% dari pasien melahirkan, sedangkan pelaksanaan KB pasca keguguran 100% 3. IMD : hasil supervisi pelaksanaan IMD 100% dari 60 pasien yang di observasi, metode yang digunakan wawancara ke pasien dengan bayi sehat.	Melakukan monitoring dan evaluasi



				4. Asi Eksklusif; hasil supervisi 100 % dari 60 pasien yang di observasi, metode yang digunakan wawancara ke pasien 5. PMK : hasil supervisi 100% dari 19 pasien yang di observasi, metode yang digunakan wawancara ke pasien 6. Perawatan BBL : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan BBL 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 7. Makan & minum ibu menyusui : hasil supervisi pelaksanaan edukasi makan minum ibu menyusui 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 8. Cek ASI : hasil supervisi pelaksanaan cek ASI 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 9. Rawat gabung: hasil supervisi pelaksanaan rawat gabung 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 10. Menyusui Bayi : hasil supervisi pelaksanaan edukasi menyusui bayi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 11. Perawatan Payudara : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan payudara 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 12. Personal Hygiene : hasil supervisi pelaksanaan edukasi personal Hygiene 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 13. Perawatan luka post sc+post partum : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan luka post op sc dan post partum 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 14. Pijat laktasi : hasil supervisi pelaksanaan edukasi pijat laktasi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien	
--	--	--	--	--	--



					Materi edukasi Tersedia elektronik dan fisik dilengkapi dengan barcode 15. Menjemur bayi : hasil supervisi pelaksanaan edukasi menjemur bayi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 16. Perawatan tali pusat : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan payudara 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 17. Memandikan bayi : hasil supervisi pelaksanaan edukasi memandikan bayi 100% dari pasien yang di observasi 60 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien. Berikut media edukasi promosi kesehatan https://sites.google.com/view/rsprimahusada/leaflet	
6	Rumah sakit menetapkan program pembinaan jejaring rujukan rumah sakit.	Ponek 1.1 EP 1	√			
7	Rumah sakit melakukan pembinaan terhadap jejaring secara berkala.	Ponek 1.1 EP 2	√		Pembinaan jejaring dilakukan pada bulan januari 2026	Melakukan monitoring dan evaluasi
8	Telah dilakukan evaluasi program pembinaan jejaring rujukan	Ponek 1.1 EP 3	√		Rujukan masuk bulan Juni yaitu 5 pasien saat merujuk sudah dilakukan penatalaksanaan awal rujukan, perujuk sudah konfirmasi ke RS	monitoring dan evaluasi



BAB V

PENUTUP

Demikian laporan Ponek bulan Juni 2026 disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Malang . Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya.

Ketua Tim PONEK

dr. Aida Musyarofah, Sp. OG

Malang, 03 Juli 2026
Direktur Rumah Sakit
Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes